

## GUIA VISUAL

### Passo a Passo da Bandagem Elástica em Cirurgias Faciais

*Blefaroplastia · Ritidoplastia · Lifting de Têmporas · Lifting de Sobrancelha*

*Setembro de 2026*

#### **SOBRE AS IMAGENS DESTA GUIA — leia antes de usar**

Este guia usa apenas fotografias e figuras já publicadas por outros autores, mantendo o crédito completo da fonte — nenhuma foto foi gerada ou inventada. Depois de uma busca nos artigos científicos citados no manual completo, apenas UM registro fotográfico foi encontrado com licença aberta (Creative Commons, que permite reprodução com crédito) mostrando de forma clara a técnica de bandagem em leque na região da face/mandíbula. Ele está no passo de Ritidoplastia/Têmporas, com a citação completa da fonte.

Para Blefaroplastia e Lifting de Sobrancelha, o registro fotográfico mais fiel à técnica exata é o do manual técnico de Cunha, Rolim, Ribeiro & Alencar (EdUnichristus, 2024) — mas esse e-book está publicado com "todos os direitos reservados", então suas fotos não podem ser reproduzidas aqui sem autorização direta dos autores/editora. Se você conseguir essa autorização por escrito, essas fotos podem ser adicionadas depois.

*Por isso, os passos abaixo estão descritos em formato visual (numerado, com tags de tensão/duração/direção), com foto real apenas onde há uma imagem de uso liberado.*

# 1. Blefaroplastia

**EVIDÊNCIA MODERADA — protocolo publicado (Cunha et al., 2024)**

**1**

## Prepare a pele

Limpe a região periocular com gaze/soro fisiológico e seque completamente.

**2**

## Corte a fita-base

Corte um segmento de kinesio tape de 10-15 cm de comprimento por 5 cm de largura.

**3**

## Corte as 3 tiras ("polvo")

2 tiras finas (pálpebra superior) + 1 tira larga (pálpebra inferior). Arredonde todas as pontas.

**PÁLPEBRA SUP.: 0,5-1 cm   PÁLPEBRA INF.: 2,5-3 cm**

**4**

## Fixe a base

Posicione a base (sem corte) ligeiramente abaixo do canto lateral do olho — sem tensão.

**TENSÃO DA BASE: 0%**

**5**

## Aplique as tiras

Estique cada tira em direção à pálpebra correspondente, contornando a cicatriz — nunca sobre ela.

**TENSÃO: 10-20%   DIREÇÃO: canto lateral → pálpebras**

**6**

## Mantenha e monitore

Deixe até a retirada dos pontos, trocando antes se sujar ou descolar. Remova se houver dor, eritema ou má perfusão.

**DURAÇÃO: até 5º-10º dia**



Ilustração de apoio (uso pessoal) — não é uma fotografia de aplicação real documentada; não reproduz o e-book de Cunha et al., 2024.

## 2. Ritidoplastia e Lifting de Têmporas

**SEM RCT ESPECÍFICO — protocolo extrapolado de cirurgia ortognática e fraturas faciais**

**1**

### **Ancore nos linfonodos**

Fixe a base (sem tensão) na região pré-auricular, submandibular e/ou cervical superior — a mais próxima da área operada.

**TENSÃO DA BASE: 0%**

**2**

### **Corte as tiras em leque**

Tiras de 1-1,5 cm de largura, base de ~5 cm sem tensão.

**3**

### **Direcione para a âncora**

Tiras dispostas em leque, acompanhando o retalho (malar/temporal → pré-auricular/cervical), tracionadas sempre em direção à base fixa.

**TENSÃO: 15-25% DIREÇÃO: retalho → linfonodo**

**4**

### **Proteja a incisão**

Nunca tracione sobre a incisão pré-auricular/temporal nem sobre bordas do retalho com risco de necrose.

**5**

### **Mantenha e reavalie**

Permanência sugerida de 5 dias, com reavaliação da viabilidade do retalho pelo cirurgião.

**DURAÇÃO: ~5 dias**

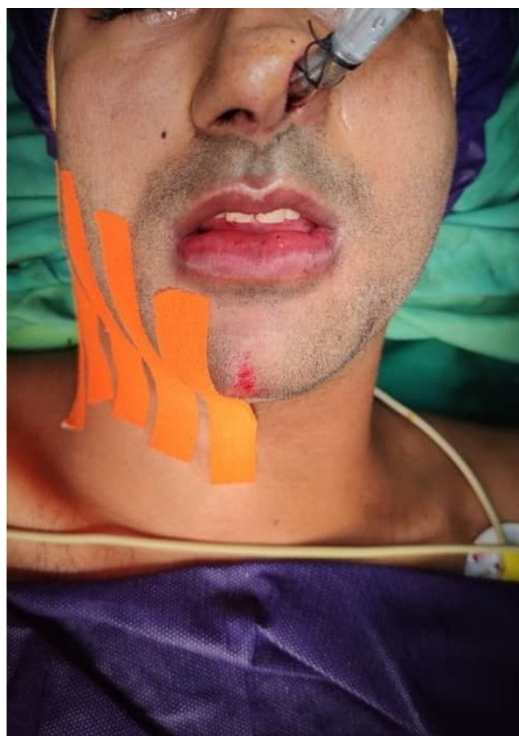


Foto real — aplicação em leque na região mandibular após cirurgia ortognática bimaxilar (mesma lógica de ancoragem/direção extrapolada para ritidoplastia e lifting de têmporas).

**Fonte: Golkar M, Taheri A, Alam M, Asadi Y, Keyhan SO. Maxillofacial Plastic and Reconstructive Surgery. 2023;45:22.**

Licença Creative Commons Atribuição 4.0 (CC BY 4.0) — [creativecommons.org/licenses/by/4.0/](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)



Ilustração de apoio (uso pessoal) — não é uma fotografia de aplicação real documentada.

### 3. Lifting de Sobrancelha

**RCT DIRETO SÓ PARA FITA DE FIXAÇÃO ESTRUTURAL — controle de edema é extrapolado**

*Atenção: existem 2 fitas diferentes nesse procedimento. A fita de fixação estrutural (mesh, ancorada no vértex com grampos, retirada em 7-10 dias) tem função de sustentação — RCT direto (Haddady-Abianeh et al., 2026). Os passos abaixo são para a bandagem elástica de controle de edema, um uso diferente e extrapolado.*

**1**

#### **Ancore na região temporal**

Base sem tensão na região temporal/pré-auricular (mesma lógica do Capítulo 2).

**TENSÃO DA BASE: 0%**

**2**

#### **Cubra a região frontal lateral**

Tiras finas em leque cobrindo a frente lateral e a cauda da sobrancelha.

**3**

#### **Direcione para a âncora**

Tração da linha média da frente em direção à âncora temporal.

**TENSÃO: 10-20% DIREÇÃO: frente → têmpora**

**4**

#### **Não sobreponha à fita estrutural**

Se a fita de fixação estrutural (mesh) ainda estiver em uso, aplique a bandagem antiedema em plano e momento distintos, sob orientação do cirurgião.

**5**

#### **Mantenha**

Componente de edema: ~5 dias. A fita de fixação estrutural segue cronograma próprio (7-10 dias).

**DURAÇÃO EDEMA: ~5 dias DURAÇÃO FIXAÇÃO: 7-10 dias**



Ilustração de apoio (uso pessoal) — não é uma fotografia de aplicação real documentada.



## 4. Procedimentos adicionais (uso pessoal)

*Fora do escopo original deste guia (blefaroplastia, ritidoplastia, têmporas e sobrancelha). Incluídos a pedido, com o mesmo cuidado de citar a fonte real onde ela existe.*

### Rinoplastia

#### EVIDÊNCIA DIRETA (RCT) — efeito depende do tipo de pele

Ozucer et al. (2016, JAMA Facial Plastic Surgery, n=57) compararam grupo controle a bandagem por 2 e por 4 semanas após rinoplastia. A bandagem reduziu significativamente a espessura da pele nasal e da região do ríntio em pacientes de pele espessa; em pele fina e na ponta nasal o efeito não foi significativo [7]. O artigo não detalha largura/tensão exatas da fita — a aplicação segue, em geral, tiras estreitas ao longo do dorso nasal, conforme orientação do cirurgião.



Ilustração de apoio (uso pessoal) — não reproduz o protocolo exato do estudo, que não detalha corte/tensão da fita.

### Bichectomia

#### EVIDÊNCIA DIRETA (RCT) — protocolo detalhado publicado

1

#### Marque 3 pontos

Ponto A no trago, ponto B na comissura labial, ponto C na protuberância mentual (linha média), com o paciente em posição relaxada.



2

### Corte 2 tiras individualizadas

Comprimento baseado nas distâncias A-B e A-C, com redução de 20% em relação à medida real. Largura de 3 cm para as duas tiras, pontas arredondadas.

3

### Aplique a primeira tira (A→B)

Leve tensão, unindo o ponto A ao ponto B.

4

### Aplique a segunda tira (A→C)

Une o ponto A ao ponto C; a borda que sai do ponto A fica imediatamente abaixo da primeira tira.

5

### Mantenha

Aplicação extraoral, sobre pele limpa com gel facial. Não aplicar sobre pele irritada nem próximo à ferida intraoral.

**DURAÇÃO: conforme protocolo do estudo (2 dias)**

*Protocolo técnico de Pelissaro et al. (2021), Research, Society and Development — estudo split-mouth randomizado e duplo-cego, com redução de edema no grupo com kinesio tape [8].*



Ilustração de apoio (uso pessoal) — não é uma fotografia do estudo original.

## Platismoplastia / Neck Lift / Lipo de Papada

**SEM ESTUDO CONTROLADO DIRETO — protocolo extrapolado**

Não foi localizado ensaio clínico controlado sobre kinesio tape em platismoplastia/neck lift ou lipoaspiração submental isolada (lipo de papada). A lógica abaixo extrapola o mesmo racional da ritidoplastia (Capítulo 2): leque submental e/ou cervical lateral, âncora pré-auricular ou mastóidea, tensão baixa a moderada, aplicação sobre pele íntegra e subordinada ao curativo/retalho definidos pelo cirurgião [1,4,5,6]. As duas variações de leque mostradas abaixo — cervical lateral e submental — seguem a mesma lógica de ancoragem, apenas direcionadas para áreas diferentes conforme a extensão do procedimento.



Ilustração de apoio (uso pessoal) — leque cervical lateral (unilateral). Protocolo extrapolado, sem estudo controlado direto.



Ilustração de apoio (uso pessoal) — leque submental bilateral (lipo de papada). Protocolo extrapolado, sem estudo controlado direto.

## 5. Sinais de alerta — remova a fita imediatamente se houver

---



### **Eritema intenso, prurido ou reação cutânea**

Sob ou ao redor da fita.



### **Dor desproporcional**

Acima do esperado para o pós-operatório.



### **Má perfusão distal**

Palidez ou cianose na área cobertas pela fita — sinal de tensão excessiva.



### **Bolhas ou lesão de pele**

Na aplicação ou na retirada da fita.

**Nunca aplique fita sobre a linha de sutura/incisão, em pele com infecção ativa, ou sobre áreas com viabilidade de retalho questionável.**

*Este guia é um resumo visual do manual completo (com toda a base científica, tabelas de evidência e referências) — consulte-o para o detalhamento e as citações completas.*